

БЕКИТЕМ
Кыргыз Республикасынын
Саламаттык сактоо министрлигинин
алдындагы Дары каражаттары жана
медициналык буюмдар
департаментинин директорунун
орун басары
Кысанов. Т.А.
« 23 » январь 2026-ж.



ДАРЫ ПРЕПАРАТЫН МЕДИЦИНАДА КОЛДОНУУ БОЮНЧА
НУСКАМА

ЦВЕТОКС РИН

Соодадагы аталышы

Цветокс Рин

Эл аралык патенттелбеген аталышы

Цетиризин

Дарынын түрү

Жука чел кабык менен капталган таблеткалар.

Курамы

1 таблетка төмөнкүлөрдү камтыйт:

Активдүү зат:

Цетиризин дигидрохлориди 10 мг;

Көмөкчү заттар:

лактоза моногидраты, микрокристаллдык целлюлоза, кросповидон, коповидон, суусуз коллоиддүү кремний диоксиди, магний стеараты, гипромеллоза, макрогол 6000, титан диоксиди, тальк, диметикон.

Сүрөттөмөсү

Бир тарабында бөлүүчү сызыгы бар, тегерек, эки жагы томпок, бир тектүү, ак түстөгү жука чел кабык менен капталган таблеткалар.

Фармадарылык тобу

Системалуу колдонуу үчүн гистаминге каршы препараттар. Пиперазинден алынгандар.

Цетиризин

АТХ коду: R06AE07

Фармакологиялык таасири

Фармакодинамикасы

Цетиризин гистаминдин атаандаш антагонисттер тобуна кирет, H_1 - гистаминдик рецепторлорду бөгөйт, антихолинергиялык жана серотонинге каршы таасирди дээрлик көрсөтпөйт. Айкын аллергияга каршы таасирге ээ, аллергиялык реакциялардын өрчүүсүн алдын алат жана жеңилдетет. Кычышууга каршы жана сууланууга каршы таасирге ээ. Аллергиялык реакциялардын «эрте» баскычына таасир берет, ошондой эле сезгенген клеткалардын көчүүсүн азайтат; аллергиялык реакциялардын «кеч» баскычында катышуучу медиаторлордун бөлүнүп чыгуусун басат. Кыл тамырлардын өткөргүчтүгүн азайтат, ткандардын шишимигинин өрчүүсүн алдын алат, жылмакай булчундун карышуусун алат. Гистаминди, мүнөздүү аллергендерди куюуга, ошондой эле муздатууга (муздак бөрү жатышта) теринин реакциясын жоготот. Дарылык дозаларда дээрлик тынчтандыруучу таасир көрсөтпөйт. Курстук ичүү маалында толеранттуулугу өрчүбөйт. 10 мг бир жолку дозасын ичкенден кийин препараттын дозасы 20 минутадан (50 % оорулууларда), 1 сааттан (95% оорулууларда) кийин башталат, жана 24 саат бою сакталат. Препаратты токтоткондон кийин таасири 3 суткага чейин сакталат.

Фармакокинетикасы

Сиңирүү: ичкенден кийин препарат ашказан-ичеги жолунда тез жана жакшы сиңирилет. Концентрациясынын эң жогорку деңгээли болжолдуу 30-60 минутадан кийин аныкталат.

Тамак ичүү сиңирүүнүн деңгээлинин чондугуна олуттуу таасир көрсөтпөйт, бирок эң жогорку концентрацияга (TC_{max}) жетүү убактысын 1 саатка узартат жана эң жогорку концентрациясынын (C_{max}) чондугун 23 %га төмөндөтөт.

Бөлүштүрүү: цетиризин кан плазма белоктору менен 93 %га байланышат. Бөлүштүрүү көлөмүнүн чондугу (V_d) төмөн (0,5 л/кг).

Зат алмашуу: цетиризин активдүү эмес метаболитти пайда кылуу менен О-деалкилирлөө жолу менен бир өлчөмдөрдө зат алмашат. 10 мг дозасында 10 күндүк колдонууда препараттын топтолуусу байкалбайт.

Бөлүп чыгаруу: негизинен өзгөрүлбөгөн түрдө болжолдуу 70 % бөйрөктөр аркылуу жүрөт. Бөйрөктөн тышкары ичеги аркылуу бөлүнүп чыгат. Системалуу клиренстин чондугу 54 мл/мин жакынды түзөт.

Жарым жартылай бөлүп чыгаруу мезгилинин чондугу 10 саатка жакынды түзөт. 6дан 12 жашка чейинки курактагы балдарда жарым жартылай бөлүп чыгаруу мезгилинин чондугу 6 саатка чейин төмөндөйт.

Бөйрөк функциясынын бузулуусунда (креатинин клиренси 11-31 мл/мин төмөн) жана гемодиализде турган бейтаптарда (креатинин клиренси 7 мл/мин төмөн) жарым жартылай бөлүп чыгаруу мезгилинин чондугу 3 эсеге көбөйөт, жалпы клиренси 70%га азаят.

Боордун өнөкөт ооруларынын фонунда жана улгайган бейтаптарда 10 мг дозасында препаратты ичүүдө жарым жартылай бөлүп чыгаруу мезгилинин чондугунун 50 %га көбөйүүсү жана системалуу клиренстин 40 %га азаюусу белгиленген.

Колдонууга көрсөтмө

- Кычышуу, чүчкүрүү, ринорея, жаш агуу, конъюнктиванын гиперемиясы сыяктуу жыл бою жана мезгилдик аллергиялык ринитти, жана аллергиялык конъюнктивитти дарылоо;
- Чөп бөрү жатышы (поллиноз);
- Бөрү жатыш, анын ичинде өнөкөт идиопатиялык бөрү жатыш, Квинке шишимиги;

- Башка аллергиялык дерматоздор, анын ичинде кычышуу жана исиркектенүү менен коштолгон атопиялык дерматит.

Каршы көрсөтмө

- активдүү заттарга же пиперазинден алынгандарга, ошондой эле препараттын башка курамындагыларга өтө сезгичтик
- креатинин клиренси 10 мл/мин төмөн оор бөйрөк алсыздыгы бар бейтаптар
- фруктозага тукум кууган көтөрүмсүздүк
- кош бойлуулук жана бала эмизүү мезгили
- 2 жашка чейинки балдар курагы

Колдонуу жолу жана дозалары

Тамак ичүүгө карабастан, чайнабастан жана жетиштүү өлчөмдөгү суюктук менен жутуп ичилет, кечинде жакшыраак.

6 дан 12 жашка чейинки курактагы балдарга:

- 30 кг.дан аз дене салмагында: жука чел кабык капталган *таблетканын* $\frac{1}{2}$, кечинде;
- 30 кг.дан көп дене салмагында: жука чел кабык капталган 1 таблеткадан, кечинде.

Күнүнө 2 жолу $\frac{1}{2}$ таблеткадан (эртең менен кечинде) ичүүгө болот.

Чоң адамдарга жана 12 жаштан жогору курактагы өспүрүмдөргө цетиризинди 1 таблеткадан кабыл алуу сунушталат, кечинде жакшыраак.

Бөйрөк алсыздыгында сунушталган дозаны 2 эсеге азайтуу керек.

Боор функциясынын бузулуусунда өзгөчө бир убакта бөйрөк алсыздыгында, дозасын жекече тандоо зарыл.

Бөйрөк функциясы кадимки *улгайган бейтаптарга* дозасын тууралоо талап кылынбайт. *Мезгилдик аллергиялык ринитте* дарылоонун узактыгы адатта 3төн 6 жумага чейинди түзөт, ал эми чаңчанын кыска мөөнөттүү таасиринде бир жума дагы жетиштүү болот.

6 жаштан жогору курактагы балдар үчүн дарылоонун узактыгы 2ден 4 жумага чейинди түзөт, аллергиянын кыска мөөнөттүү таасиринде 1 жума бою ичкен жетиштүү.

Кыйыр таасири

- уйкусуроо, баш оору, баш айлануу, алсыроо, талмоорсуу, чарчоо, сезимдин бузулуулары
- кыжырдануу, дүүлүгүү, коркуу, маң болуу
- ичтин оорушу, ооздун кургашы, окшуу, ич өтүү
- колко карышуусу, фарингит жана ринит (балдарда)
- кычышуу, бөртмө

сейрек:

- өтө сезгичтик, бөрү жатыш, шишимик
- тахикардия
- боор ферменттеринин, щелочтуу фосфатаза, билирубиндин деңгээлинин жогорулашы
- салмактын көбөйүүсү
- карышуулар, кыймылдын бузулуулары
- агрессивдүүлүк, акыл-эстин чаташуусу, чүнчүү, галлюцинациялар, уйкусуздук

абдан сейрек:

- ангионевротикалык шишимик, эритема, анафилактикалык шок
- заара ушатуунун кыйындышы, дизурия, энурез
- тромбоцитопения

- даам сезүүнүн бузулушу, эси ооп калуу, титирөө, дистония, дискинезия, булчундардын тарткылоолору
- көздүн сезгенүүсү, көрүүнүн же көз чанагынын кыймылынын бузулуусу
белгисиз
- табиттин жогорулашы, суициддик ойлор, амнезия, эс-тутумдун бузулуусу, зааранын кармалуусу.

Ашыкча доза

Цветокс Рин препаратын 50 мг дозасында бир жолу ичүүдө төмөнкү симптомдор байкалат: ман болуу, ич өтүү, баш айлануу, жогору чарчоо, баш оору, талмоорсуу, мидриаз, кычышуу, алсыздык, тынч алдыруучу таасир, уйкусуроо, кеңгирөө, тахикардия, титирөө, зааранын кармалышы.

Дарылоо: препаратты ичкенден кийин дароо – ашказанды жууп тазалоо же кусууну жасалма пайда кылуу. Активдешкен көмүрдү дайындоо, оору белгилерине жараша жана колдоочу дарылоону жүргүзүү сунушталат. Атайын антидоту жок. Гемодиализ натыйжасыз.

Башка дары каражаттары менен өз ара таасири

Цетиризиндин жана псевдоэфедриндин, антипириндин, циметидиндин, кетокконазолдун, эритромициндин, азитромицин глипизиддин, диазепамдын өз ара таасирин фармакологиялык изилдөөлөр жагымсыз өз ара таасирлерине эч кандай далилдерди аныктаган эмес.

Теофиллиндин (суткасына бир жолу 400 мг) дозаларын жана цетиризинди изилдөөнүн бир нече изилдөөлөрүндө цетиризиндин клиренсинин бир аз (16%) төмөндөшү, ошол эле убакта теофиллиндин жайгашуусу цетиризинди бир убакта дайындоодо өзгөрүлгөн эмес. Цетиризинди макролиддер (мисалы, азитромицин, эритромицин) же кетокконазол менен бир убакта дайындоо ЭКГда клиникалык маанилүү өзгөрүүлөргө алып келген эмес.

Ритонавирдин (600 мг суткасына эки жолу) жана цетиризиндин (күнүнө 10 мг) бир нече дозаларын изилдөөдө цетиризиндин таасир берүү деңгээли болжолдуу 40%га, ал эми ритонавирдин жайгашуусу цетиризинди коштоп ичүүгө кошумча бир аз өзгөргөн (-11%). Цетиризин натрий гепариндин антикоагулянттык таасирин азайтат. Азеластин, алпразолам, бупренорфин, галоперидол, гидроксизин, диазепам, дроперидол, золпидем, флуразепам, кветиапин, флуфеназин, клозапин, трифлуоперазин, тиоридазин, фенобарбитал, фентанил, темазепам, рисперидон, пропофол, ремифентанил, прометазин, перфеназин, кодеин, лоразепам, оланзапин, оксазепам, мидазолам, хлорпромазин, хлордиазепоксид, эстазолам – депримациясын (өз ара) жана психомотордук реакциялардын ылдамдыгынын төмөндөшүн күчөтөт.

Наркоздон кийинки мезгилде метогекситал, кетамин, изофлуран, энфлуран - депримациясын (өз ара) жана психомотордук реакциялардын ылдамдыгынын төмөндөшүн күчөтөт. Этанол - депримациясын (өз ара) жана психомотордук реакциялардын ылдамдыгынын төмөндөшүн күчөтөт; дарылоо убагында спирт ичимдиктеринен баш тартуу зарыл.

Цетиризиндин сиңирүү деңгээли тамак ичүүдө азайбайт, бирок сиңирүү ылдамдыгы 1 саатка төмөндөйт.

Тери аллергиясына тесттер антигистаминдер менен басылат, алардын чыгышы 3 күн ичинде жүрөт, аларды аткаруунун алдында буга көңүл буруу сунушталат.

Өзгөчө көрсөтмө

Өтө сезгичтик реакциясынын өрчүшүндө препарат менен дарылоону токтотуу керек. Бөйрөк алсыздыгы бар бейтаптарда препараттын бөлүнүп чыгуусу жай болгонунан байланыштуу анын топтолуусу мүмкүн. Мындай бейтаптарга Цветокс Ринди адаттагы сунушталган чоң адамдар

үчүн дозасын дайындоодо, холинобөгөөчү таасири жана борбордук нерв системасына таасири менен байланышкан кыйыр таасирлери белгилениши мүмкүн, мындай учурларда дозасын төмөндөтүү сунушталат.

Жогору сезгичтиги бар бейтаптарда препаратты алкоголь же БНС башка депрессанттары менен бир убакта колдонуу көңүл буруунун кошумча төмөндөшүн жана иштөөнү начарлатышы мүмкүн.

Заараны кармоочу факторлорго жакындыгы бар бейтаптарга өзгөчө көңүл буруу сунушталат, себеби цетиризин зааранын кармалышы коркунучун көбөйтүшү мүмкүн.

Улгайган курактагы бейтаптарда препараттын холинобөгөөчү таасиринин өрчүү коркунучу ошондой эле жогорулайт (ооздун кургашы, зааранын кармалышы). Бул симптомдор пайда болушунда препарат менен дарылоону токтотуу керек. Цветокс Рин менен дарылоону сынамдардын жыйынтыктарынын бурмаланышын алдын алуу үчүн аллергендер менен теринин сынамдарын жүргүзүүгө чейин 3 күн мурун токтотуу керек.

Препаратты дарылык дозаларда колдонууда алкоголь (канда алкогольдун 0,5 г/л концентрациясында) менен өз ара таасири жөнүндө маалыматтар алынган эмес, бирок алкоголь менен бир убакта ичүү коркуу же буйдалуу сезимин пайда кылышы мүмкүн. Эпилепсиясы бар оорулууга жана карышуунун өрчүү коркунучу бар бейтаптарга жогору көңүл буруу сунушталат.

Унаа каражаттарын же потенциалдуу кооптуу механизмдерди башкаруу жөндөмдүүлүгүнө дары каражатынын таасир берүү өзгөчөлүгү

Автомобилди айдоого жана механизмдер менен иштөөгө жөндөмдүүлүгүн объективдүү баалоодо 5 мг сунушталган дозасын дайындоодо кандайдыр бир жагымсыз көрүнүштөр ишенимдүү аныкталган эмес, ошондой болсо да, көңүл буруунун жогору концентрациясын жана психомотордук реакциялардын тездигин талап кылган ишмердиктин потенциалдуу кооптуу түрлөрү менен алектенүүдөн кармануу максатка ылайыктуу.

Чыгаруу формасы

Поливинилхлорид/поливинилиденхлорид жана алюминий фольгадан плёнкадан контурлуу уячалуу таңгакка 10 таблеткадан салынган.

2 контурлуу уячалуу таңгак медицинада колдонуу боюнча нускамасы менен картон кутуга салынган.

Сактоо шарты

25°C дан жогору эмес аба табында өзүнүн таңгагында сакталат.

Балдар жетпеген жерде сактоо керек!

Жарактуулук мөөнөтү

3 жыл. Жарактуулук мөөнөтү аяктагандан кийин колдонууга болбойт.

Берүү шарты

Рецепти жок.

Соода маркасынын жана каттоо күбөлүгүнүн ээси:

Vegapharm LLP

Unit 18, 53 Norman Road, Greenwich Centre Business Park

Лондон, SE10 9QF, Улуу Британия

Өндүрүүчү

Replek Farm Ltd., Skopje

Kozle Str. 188, 1000 Skopje

Түндүк Македония Республикасы

Кыргыз Республикасынын аймагында керектөөчүлөрдөн продукттун сапаты боюнча арыз доолорду кабыл алуучу уюмдун дареги:

«Аман Фарм» ЖЧК Бишкек ш, Кыргыз Республикасы, Тыныстанов көчөсү, 4а үй, 11-батир,

E-mail: amanpharm.company@gmail.com